

Cáncer de ovario — diagnóstico y estadificación

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de ovario** es el **tumor ginecológico más letal** debido a que suele diagnosticarse en etapas avanzadas, cuando ya existe **compromiso peritoneal o metastásico**.

En Chile, según datos del **MINSAL y GES (2023)**, representa cerca del **5% de todos los cánceres en mujeres** y tiene una **mortalidad cercana al 60% a los 5 años**, por su presentación silenciosa y falta de métodos de tamizaje eficaces.

La mayoría de los casos corresponde a **tumores epiteliales**, aunque también existen variantes **germinales** y **del estroma gonadal**.

☐ En EUNACOM suelen preguntar:

- Cuál es el **principal factor de riesgo**.
 - Qué **examen inicial y marcador tumoral** debe solicitarse.
 - En qué casos se **deriva a ginecología oncológica**.
 - Cómo se **clasifica según FIGO** y cómo se **maneja quirúrgicamente**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Origen

El **epitelio superficial del ovario (mesotelio)** sufre **repetidos procesos de ruptura y reparación** durante la ovulación.

Cada ovulación implica inflamación local, liberación de radicales libres y proliferación reparadora, lo que **aumenta el riesgo de mutaciones**.

Por eso, **la ovulación repetida** a lo largo de la vida es un factor predisponente.

☐ “Más ovulaciones = mayor riesgo de cáncer de ovario.”

b. Factores de riesgo

Aumentan el riesgo	Disminuyen el riesgo
Edad >50 años	Multiparidad
Historia familiar de cáncer de ovario o mama (BRCA1/2)	Uso prolongado de anticonceptivos orales
Nuliparidad	Lactancia prolongada
Menarquia precoz / menopausia tardía	Ligadura tubaria / histerectomía
Endometriosis	—
En Chile, el BRCA1/2 positivo se asocia a riesgo acumulado de hasta 40–60% de cáncer ovárico .	

c. Tipos histológicos

Grupo	Ejemplo	Frecuencia
Epiteliales	Seroso, mucinoso, endometriode, células claras	80–90%
Germinales	Disgerminoma, teratoma inmaduro, seno endodérmico	10–15% (jóvenes)
Estroma gonadal	Tumor de la granulosa, Sertoli-Leydig	5–10%

3. Clínica

El cáncer de ovario es conocido como el “**asesino silencioso**”, porque sus síntomas son **vagos y tardíos**.

a. Síntomas iniciales (inespecíficos)

- Distensión o aumento del perímetro abdominal.
- Sensación de plenitud o saciedad precoz.
- Dolor o molestia pélvica crónica.
- Trastornos digestivos (flatulencia, dispepsia).
- Aumento de peso o masa palpable.

b. Síntomas avanzados

- Ascitis.
- Disnea por derrame pleural.
- Pérdida de peso.
- Síntomas urinarios o intestinales por compresión.

☐ **Metrorragia posmenopáusica NO es típica** de cáncer ovárico (más de endometrio).

4. Examen físico

- **Abdomen globuloso, distendido, con matidez cambiante** (ascitis).
 - **Masa anexial fija, irregular o bilateral.**
 - **Nódulos en fondo de saco (Douglas) o palpación de ganglios inguinales.**
 - En etapas avanzadas: caquexia, dolor abdominal, derrame pleural.
-

5. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias principales
Quistes funcionales	Pequeños, uniloculares, involucionan espontáneamente
Endometrioma	Mujeres jóvenes, ecografía típica “vidrio esmerilado”
Cistoadenomas benignos	Grandes pero de paredes delgadas
Tumores metastásicos (Krukenberg)	Bilaterales, antecedente digestivo
Miomas subserosos	Masa sólida separada del ovario

6. Exámenes complementarios

a.

Ecografía transvaginal (de elección inicial)

Característica	Sugiere benignidad	Sugiere malignidad
Pared	Fina, regular	Gruesa, irregular
Contenido	Anecoico	Sólido o mixto
Tabiques	Finos, pocos	Gruesos, múltiples

Papilas	Ausentes	Presentes, vascularizadas
---------	----------	------------------------------

Bilateralidad	No	Sí
---------------	----	----

Ascitis	Ausente	Presente
---------	---------	----------

☐ Masa **compleja, sólida o papilar con ascitis** → **derivar a oncología.**

b.

Marcadores tumorales

Marcador	Utilidad clínica	Tumor asociado
CA-125	Principal marcador epitelial	Seroso / endometriode
HE4 (Human Epididymis Protein 4)	Mayor especificidad; usado en algoritmo ROMA	Tumores epiteliales
AFP	Tumores del seno endodérmico	Germinales
β-hCG	Coriocarcinoma, disgerminoma mixto	Germinales
LDH	Disgerminoma	Germinales
Inhibina / Estradiol	Tumor de la granulosa	Estromales

CA-125 >35 UI/ml es anormal, pero puede elevarse en endometriosis, EIP o embarazo.

c.

Algoritmo de riesgo maligno (RMI y ROMA)

- **RMI = $U \times M \times \text{CA-125}$**
 - U = puntuación ecográfica (0–3)
 - M = menopausia (1 = pre, 3 = post)
 - RMI >200 → alto riesgo de malignidad
- **ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)**

Combina CA-125 + HE4 + estado menopáusico → más específico.

d.

Imágenes complementarias

- **TAC / RM:** etapificación y evaluación de extensión (omentos, peritoneo, hígado).
 - **Radiografía / TC de tórax:** descartar metástasis pleural o pulmonar.
-

7. Diagnóstico histológico

Se confirma mediante **biopsia quirúrgica o citología peritoneal**.

La punción percutánea (PAAF) no se recomienda de rutina por riesgo de diseminación.

8. Clasificación FIGO 2021 — Etapificación quirúrgica

Etap	Descripción
------	-------------

I	Limitado al ovario o trompa
---	-----------------------------

II Compromete pelvis (útero, vejiga, recto)

III Metástasis peritoneales o ganglios
retroperitoneales

IV Metástasis a distancia (pleural, hepática)

☐ En la práctica, **70% de los casos se diagnostican en etapa III o IV.**

9. Tratamiento

a.

Cirugía citorreductora primaria (tratamiento estándar)

Objetivo: **extirpar todo tumor visible.**

Procedimiento:

- Histerectomía total + salpingooforectomía bilateral.
- Omentectomía infracólica.
- Linfadenectomía pélvica y paraaórtica.
- Lavado peritoneal y biopsias múltiples.

Si la paciente es joven con etapa I y deseo de fertilidad → se puede conservar el ovario contralateral y el útero.

b.

Quimioterapia adyuvante (epiteliales)

- **Carboplatino + Paclitaxel** (6 ciclos).
- En etapas III–IV o enfermedad residual.

- Terapia de mantenimiento con **bevacizumab** o **olaparib (mutación BRCA)** según protocolo.
-

c.

Tumores germinales

- Cirugía conservadora (unilateral).
 - Quimioterapia BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino).
 - Supervivencia >90%.
-

d.

Tumores del estroma (granulosa)

- Histerectomía total + anexectomía bilateral.
 - Monitoreo con **inhibina** y **estradiol**.
-

10. Seguimiento

- Control cada 3–6 meses los primeros 5 años.
 - Examen físico, CA-125 y ecografía.
 - TAC o RM si sospecha de recurrencia.
 - En portadoras BRCA: seguimiento genético familiar.
-

11. Complicaciones

Tipo	Ejemplo
Agudas	Torsión, hemorragia, rotura del tumor
Crónicas	Recurrencia peritoneal, ascitis, obstrucción intestinal
Metabólicas	Caquexia, hipoproteinemia
Quimioterapia	Mielosupresión, neuropatía periférica

12. Pronóstico

Depende de la etapa al diagnóstico:

Etapa FIGO	Supervivencia a 5 años
I	80–90%
II	60–70%
III	20–40%
IV	<10%

- ☐ La **citorreducción completa** es el factor pronóstico más importante.
-

13. Prevención y pesquisa precoz

- **No existe tamizaje efectivo** en población general.
 - En portadoras de **BRCA1/2**:
 - Seguimiento con CA-125 + ecografía semestral.
 - Considerar **salpingooforectomía profiláctica** a los 35–40 años o tras paridad cumplida.
 - Uso prolongado de **ACO combinados (>5 años)** reduce riesgo en 40–50%.
-

14. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Principal factor de riesgo:** historia familiar y mutación BRCA1/2.
2. **Síntomas inespecíficos:** distensión, saciedad precoz, masa abdominal.
3. **CA-125 >35 UI/ml** + masa compleja = sospecha.
4. **RMI >200** → **derivar a ginecología oncológica.**
5. Diagnóstico definitivo es **histológico.**
6. Tratamiento estándar: **cirugía citorreductora + quimioterapia (carboplatino/paclitaxel).**
7. **No hay screening eficaz;** la prevención se basa en **ACO y profilaxis genética.**



Errores comunes

- No solicitar β -hCG en mujer joven (descartar tumor germinal).
- Puncionar masa ovárica sospechosa (riesgo de diseminación).

- No derivar a especialista ante masa compleja o CA-125 elevado.
 - Interpretar quistes simples en posmenopáusica como benignos sin estudio.
 - No considerar cáncer de ovario ante ascitis inexplicada.
-

15. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **cáncer de ovario** es el tumor ginecológico **más letal**, por diagnóstico tardío.
2. **CA-125 y ecografía transvaginal** son herramientas iniciales clave.
3. **RMI >200 o masa compleja → derivar a oncología.**
4. Principal tipo: **carcinoma epitelial seroso.**
5. Tratamiento: **cirugía citorreductora + quimioterapia (carboplatino/paclitaxel).**
6. **BRCA1/2** confiere riesgo alto; considerar **profilaxis quirúrgica.**
7. **No hay screening efectivo** en población general.